

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	結束血液透析評核表	編號	A31000-Q06-F-B50
			版本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	113 年 12 月 17 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：血液透析護理人員。

二、評核方式：

1. 實際操作或口述。
2. 評核護理記錄。

三、評核內容：

1. 當脫水量及透析治療時間完成時，壓  變成 ，並測量病人透析後血壓及詢問病人是否有不適症狀。依醫囑由靜脈端橡皮袖或 V-chamber line 處給藥，例如：EPO、Calcijex…等藥物。記錄病人透析後血壓及血液透析機面版上實際的透析時間、總脫水量。每月月初需抽生化血時，則於透析治療時間及脫水量完成時，壓  變成 ，並將血液流速調降為 150ml/min，2 分鐘後再由動脈端橡皮袖抽取透析後生化血。
2. 關掉 Blood Pump，將原掛於血液透析機 IV stand 上的 0.9%N.S. 透過輸液套(IV Set)接於 T-line 處，打開 0.9%N.S 與 IV Set 上的開關閥，使用 kelly 或動脈血液迴路管管夾，將 T-line 下方血液迴路管夾住，啟動 Blood Pump，先將 T-line 前端血液趕一小段後，再將 Blood Pump OFF，移除 kelly 或鬆開動脈血液迴路管管夾後，以擠壓方式將動脈血液迴路管前端的血液趕回體內，待趕血乾淨後夾住動脈端安全穿刺針之管夾及動脈血液迴路管管夾。
3. 開啟 Blood Pump，血液流速設定在 150ml/min，將血液經由靜脈血液迴路管完全趕回體內後，關閉 Blood Pump，夾住靜脈瘻管穿刺針之管夾及靜脈血液迴路導管管夾。
4. 排空人工腎臟及 B 粉。
 - a. 將動、靜脈血液迴路管互相銜接，靜脈腔上段的管路反摺，藍色外管以塞子塞住
 - b. 壓排空人工腎臟鍵 ，螢幕提示“排空透析器嗎？”按確認“”，將透析器藍端接頭連接至沖洗橋上機器會自動排空透析器，待排空後將紅端連接至沖洗橋上。
 - c. 排空 B 粉桶：排空人工腎臟後，壓  鍵，B 粉桶排空水份，接回 A 液接頭。
5. 機器消毒
 - a. 班消：選擇消毒鍵，螢幕左上方壓  鍵。
 - b. 末班消毒：選擇消毒鍵，螢幕左上方壓  鍵後再壓  進入自動開機畫面壓下啟動，此時機器執行末班消毒並自動關機，且明天在設定時間自動開機。
6. 取 3×3 無菌紗布對摺二次，輕放於動脈針眼處，拔除動脈端安全穿刺針，快速以無菌紗布加壓針眼止血；再取 3×3 無菌紗布對折二次，輕放於靜脈針眼處，拔除靜脈端安全穿刺針，快速以無菌紗布加壓針眼止血。拔針前更換一副新的手套。若病人有不適症狀或血壓偏低情形，則暫緩拔除靜脈端安全穿刺針，待血壓穩定後，再予拔除。
7. 拔除安全穿刺針後，穿刺部位加壓 5-10 分鐘（視病人情況而定），如未出血則移除紗布貼上 Pushband 止血繃帶。
8. 將血液透析機上的東西收拾乾淨，並使用泡製過 0.05%次氯酸鈉的擦拭紙巾，擦拭血液透析機。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	結束血液透析評核表	編 號	A31000-Q06-F-B50
			版 本	第 2.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	113 年 12 月 17 日
			頁數/總頁數	2/2

9. 記錄結束透析時間，透析器凝固情形：依透析器凝固程度可分 Clear、+、++、+++、Complete clot。

- 透析後 A.K.無凝固（Clear）。
- 若透析器凝固<10%，則記錄為(+)。
- 若透析器凝固>10~50%，則記錄为(++)。
- 若透析器凝固>50%，則記錄為(+++)。
- 若透析器完全凝固。

10. 協助測量體重，計算脫水量並記錄。

11. 護理記錄：記錄此次透析中之特殊情形及透析後的主訴。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容											正確率 (%)	備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以—表示
 4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%